NEURODIVERGENCIA Y REDES SOCIALES

Estudio ampliado: información, desinformación, identidad, comunidad, amistad, accesibilidad, autopercepción, autodiagnóstico, bienestar, ciberacoso, uso problemático y vacíos de investigación

ALCANCE DE ESTA VERSIÓN

Actualización ampliada con búsqueda documental realizada hasta el 7 de octubre de 2026. Integra la versión anterior de FAND con revisiones sistemáticas, estudios longitudinales, experimentales, cualitativos y análisis de contenido. **No se presenta como una revisión sistemática registrada**: es una síntesis documental amplia y trazable orientada a divulgación y planificación de FAND.

27	21	32	44
estudios en la revisión 2026 sobre calidad y desinformación	reportes / 18 estudios sobre conexión social en autismo y TDAH	estudios / 3.026 personas autistas en revisión de comunicación digital	estudios en jóvenes con dificultades de lenguaje/comunicación

CONCLUSIÓN EN UNA FRASE

Las redes pueden ser simultáneamente espacio de comunidad y apoyo y canal de desinformación, sobrecarga o daño; el efecto depende de quién las usa, para qué, en qué plataforma, con qué apoyos y con qué calidad de información.

1. CÓMO SE HA AMPLIADO LA BÚSQUEDA

La ampliación se orientó a cinco bloques: (1) calidad y fiabilidad de la información; (2) conexión social, identidad y apoyo; (3) bienestar, autoestima, ciberacoso y uso problemático; (4) autopercepción, diagnóstico y efectos de la desinformación; y (5) accesibilidad y perfiles menos estudiados.

Tipo de evidencia	Qué aporta	Precaución al interpretarla
Revisiones sistemáticas / scoping reviews	Panorama global, consistencia y vacíos	Heterogeneidad de definiciones, plataformas y medidas
Estudios longitudinales	Orden temporal y cambios	No eliminan todos los factores de confusión
Experimentos	Efecto de una exposición controlada	Contexto artificial y muestras concretas
Entrevistas / cualitativos	Experiencia vivida, identidad y matices	No estiman prevalencia
Análisis de contenido	Qué información circula y con qué calidad	No demuestra el efecto que produce en cada usuario
Minería de Reddit/X	Temas y lenguaje a gran escala	Usuarios no equivalen a población clínica representativa

REGLA DE INTERPRETACIÓN

En todo el informe se separan **correlación, asociación, experiencia personal y causalidad**. Un contenido puede ser popular sin ser correcto; una persona puede reconocerse legítimamente en experiencias online sin que eso constituya un diagnóstico; y una asociación estadística entre uso de redes y síntomas no demuestra por sí sola qué causa qué.

2. MAPA DE LA EVIDENCIA: NO TODAS LAS NEURODIVERGENCIAS ESTÁN IGUAL DE ESTUDIADAS

Perfil	Nivel relativo de evidencia	Temas más frecuentes	Vacíos principales
Autismo	Alto	Comunidad, identidad, comunicación, TikTok, ciberacoso, diseño	Más causalidad, diversidad cultural y edad avanzada
TDAH	Alto	TikTok, desinformación, uso problemático, autoestima, longitudinales	Más estudios clínicos y mecanismos causales
Discapacidad intelectual	Medio	Inclusión, amistad, privacidad, seguridad, alfabetización, acceso	Intervenciones y seguimiento longitudinal
Lenguaje / comunicación	Medio-bajo	Uso social, barreras comunicativas, apoyos	Investigación codiseñada y longitudinal
Tourette / tics	Medio-bajo	Representación, comunidades, tics funcionales	Diferenciar percepción online, Tourette y FTLB
DCD / disprasia	Bajo	Experiencias vitales, estrategias, trabajo, apoyo	Plataformas, bienestar y estudios comparativos
Dislexia	Bajo	Accesibilidad, lectura/escritura digital	Redes sociales actuales y efectos sociales
Discalculia / disgrafía / otros	Muy bajo	Evidencia específica escasa	Prácticamente todas las dimensiones

SESGO DEL CAMPO

La ausencia de estudios no significa ausencia de necesidades. Significa que **sabemos mucho menos**. Por ello FAND no debe extrapolar automáticamente los hallazgos de autismo o TDAH a todas las neurodivergencias.

3. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DESINFORMACIÓN

La revisión sistemática de Carter et al. (2026) es especialmente útil porque compara estudios sobre salud mental y neurodivergencia en varias plataformas.

27	5.057	0-56,9 %	2026
estudios incluidos	publicaciones analizadas	rango de desinformación entre estudios	año de publicación

PATRÓN GENERAL

La prevalencia de desinformación varió mucho según tema, plataforma y método. En conjunto, fue mayor en TikTok que en YouTube y mayor en contenidos de neurodivergencia que en otros temas de salud mental.

QUIÉN PRODUCE EL CONTENIDO

La calidad y fiabilidad fueron variables, pero tendieron a ser mejores cuando el contenido estaba creado por profesionales.

QUÉ NO SIGNIFICA EL 0-56,9 %

No significa que 'hasta el 56,9 % de todas las redes sea falso'. Es el rango observado entre estudios distintos, con muestras, definiciones y plataformas diferentes. La heterogeneidad impide convertirlo en una prevalencia universal.

4. AUTISMO: INFORMACIÓN, REPRESENTACIÓN Y EXPERIENCIA

133	27 %	41 %	32 %
vídeos informativos #Autism	correctos	incorrectos	sobregeneralizados

En Aragon-Guevara et al., los 133 vídeos informativos más vistos sumaban 198,7 millones de visualizaciones y 25,2 millones de 'me gusta'. No hubo diferencias significativas de engagement entre contenido correcto e incorrecto/sobregeneralizado, y los vídeos de profesionales sanitarios tenían más probabilidad de ser correctos.

TIKTOK Y DIAGNÓSTICO EN ADULTOS

Un estudio de 2025 analizó 150 vídeos asociados a #actuallyautistic, #latediagnosedautistic y #autism. Encontró una proporción importante de vídeos personales o engañosos, diferencias entre hashtags y mucho contenido centrado en identidad y diagnóstico. Su alcance muestra el potencial de TikTok para concienciación y autoexploración, pero también la necesidad de alfabetización digital.

REPRESENTACIÓN TAMBIÉN ES CALIDAD

Otro análisis de vídeos #autism mostró que gran parte del contenido muy visto presenta experiencias personales de personas autistas. Entre los vídeos con una persona autista, la representación racial estaba muy concentrada en personas percibidas como blancas. Esto puede limitar que ciertos grupos encuentren referentes que reflejen simultáneamente neurodivergencia y diversidad racial.

5. AUTISMO: CONEXIÓN, IDENTIDAD, COMUNIDAD Y RIESGOS

32	3.026	15	78
estudios de comunicación digital	personas autistas incluidas	estudios en revisión específica de experiencia en redes	adultos en estudio de ciberacoso

BENEFICIOS DESCRITOS

Más control sobre cuándo y cómo responder; menor presión social para algunas personas; acceso a pares con experiencias similares; identidad y pertenencia; intercambio de estrategias; posibilidad de comunicación alrededor de intereses compartidos.

RIESGOS DESCRITOS

Ciberacoso, rechazo, sentirse ignorado, malentendidos, privacidad, engaño, vulnerabilidad, soledad en determinados contextos y sobrecarga.

CIBERACOSO Y PERTENENCIA

En un estudio con 78 adultos autistas, mayor uso de redes se asoció con mayor riesgo de cibervictimización. A la vez, la autoestima se relacionó positivamente con el sentimiento de pertenecer a una comunidad online y negativamente con sentirse ignorado. Es un buen ejemplo de por qué la experiencia online no puede resumirse como 'buena' o 'mala'.

INTERVENCIONES BASADAS EN REDES

Una revisión de 2023 encontró solo 9 artículos sobre intervenciones mediante redes sociales en autismo: 8 estudios primarios y 1 revisión; los estudios primarios reunían 164 participantes autistas de 5 a 22 años. Los resultados fueron mayoritariamente positivos, pero la base de evidencia se consideró todavía pequeña y de calidad limitada.

6. TDAH: QUÉ CIRCULA EN TIKTOK

100	52 %	27 %	21 %
vídeos populares analizados	engañosos	experiencia personal	útiles

En Yeung et al., los vídeos de experiencia personal fueron los más comprensibles y los más populares. Entre los 52 vídeos engañosos, el problema más común fue presentar síntomas transdiagnósticos -por ejemplo ansiedad, depresión, ira o cambios de ánimo- como si fueran específicos de TDAH.

50	46	92 %	4 %
vídeos #ADHDtest	clasificados como engañosos	del total	de los 'me gusta' fueron para vídeos útiles

En el estudio #ADHDtest, los vídeos útiles concentraron solo el 4 % de los 'me gusta', el 1 % de los comentarios y el 7 % de los favoritos. La muestra ilustra que **la interacción no funciona como control de calidad**.

REVISIÓN SISTEMÁTICA 2026

Branigan revisó cinco estudios considerados de alta calidad. En las muestras analizadas por esos trabajos, el contenido engañoso osciló aproximadamente entre 48,7 % y 92 %. La revisión destaca la patologización de comportamientos cotidianos, la fuerza de las narrativas personales y la posible interacción entre desinformación, validación entre pares y recomendación algorítmica.

7. TDAH: QUÉ PASA CUANDO UNA PERSONA VE DESINFORMACIÓN

EXPERIMENTO CON 490 UNIVERSITARIOS

Participantes sin tratamiento previo fueron asignados aleatoriamente a tres condiciones: información correcta sobre TDAH, desinformación sobre TDAH o contenido de control. Se midió conocimiento antes y después, además de confianza, estigma e intención de buscar tratamiento.

RESULTADO 1

Quienes vieron desinformación mostraron **menos conocimiento correcto sobre TDAH** después de la exposición.

RESULTADO 2

A pesar de ello, mostraron **mayor confianza en su conocimiento**. La combinación de menor exactitud y mayor seguridad es especialmente relevante para la alfabetización digital.

LO QUE ESTE EXPERIMENTO NO DEMUESTRA

No demuestra cuántas personas se autodiagnostican falsamente ni cuántas 'realmente tienen TDAH'. Tampoco demuestra que TikTok cause TDAH. Sí aporta evidencia experimental de que la exposición a información incorrecta puede modificar negativamente el conocimiento y la confianza sobre el trastorno.

CADENA DE RIESGO POSIBLE

Paso	Proceso
1	Contenido simplificado, atractivo o incorrecto
2	Identificación con rasgos comunes o transdiagnósticos
3	Recomendación de contenido similar por la plataforma
4	Repetición y validación social
5	Mayor seguridad subjetiva en una explicación
6	Posible autodiagnóstico, búsqueda de evaluación o adopción de una identidad diagnóstica

Esta secuencia es un **modelo de riesgo plausible**, no una cadena causal demostrada en todas sus etapas.

8. TDAH Y USO PROBLEMÁTICO: QUÉ DICE LA EVIDENCIA

15	35.223	r = 0,361	0,297-0,421
estudios en metaanálisis	participantes	correlación combinada	IC 95 %

El metaanálisis de Ding et al. (2025) encontró una asociación positiva moderada entre sintomatología de TDAH y uso problemático de redes sociales. La intensidad de la asociación variaba según el momento de recogida de datos, las escalas empleadas y la edad media de las muestras.

CORRELACIÓN NO ES CAUSALIDAD

Este resultado no permite afirmar que las redes causen TDAH ni que el TDAH cause inevitablemente uso problemático. Factores como impulsividad, regulación emocional, sueño, estrés, apoyo social, diseño de plataforma y otros problemas de salud mental pueden intervenir.

REVISIÓN DE ADOLESCENTES 2026

Una revisión sistemática específica estudió la relación entre uso de redes e inatención/impulsividad en adolescentes de 10 a 19 años, incluyendo tanto población general como jóvenes con TDAH. Refuerza la necesidad de distinguir entre cantidad de uso, uso problemático y resultados atencionales.

9. CONEXIÓN SOCIAL Y AUTOESTIMA: AUTISMO Y TDAH NO SE HAN ESTUDIADO IGUAL

21	18	16	11/5
reportes	estudios de conexión/desconexión	estudios sobre autoestima	infantojuveniles / adultos en autoestima

AUTISMO

La revisión de conexión social sugiere una relación con mayor conexión online; los estudios de autoestima incluyen comunidad, pertenencia y también ciberacoso. La comunidad online se relaciona con identidad, conexión y mayor autoestima en algunos estudios.

TDAH

La literatura se ha centrado más en uso problemático/adictivo y ciberacoso. En la revisión de autoestima, estos fenómenos se asociaron con menor autoestima.

IMPORTANTE: POSIBLE SESGO DE PREGUNTA

Parte de la diferencia entre autismo y TDAH puede reflejar **qué decidió estudiar cada literatura**. Si los estudios sobre autismo preguntan más por comunidad y los de TDAH más por adicción o riesgo, los resultados no son comparables de forma neutral. Las revisiones de 2026 señalan problemas de medición y predominio de diseños transversales.

10. DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DIFICULTADES DE LENGUAJE/COMUNICACIÓN

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Las revisiones describen amistad, inclusión, identidad, disfrute y autonomía, junto con riesgos de explotación, bullying, privacidad, alfabetización, coste y diseño inaccesible. Una revisión sistemática cualitativa de 2025 actualiza las razones y motivaciones para el uso social de internet.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Una revisión de alcance de 2024 incluyó 44 estudios. Los jóvenes con trastornos del lenguaje usan redes con fines sociales, aunque en conjunto menos que sus pares; su perfil comunicativo influye en qué plataformas y formatos pueden utilizar.

DISEÑO Y APOYOS

Las dificultades no deben atribuirse únicamente a la persona. Lectura y escritura intensivas, lenguaje implícito, navegación compleja, configuraciones de privacidad y ausencia de apoyos pueden convertir una plataforma ordinaria en un entorno poco accesible.

11. TOURETTE/TICS Y DCD-DISPRASIA

TOURETTE Y TICS FUNCIONALES

Durante la pandemia se describieron adolescentes con inicio explosivo de conductas tipo tic y exposición previa a contenido de tics en redes. Estos cuadros se conceptualizaron como tics funcionales / conductas funcionales tipo tic, **no como Tourette causado por TikTok**. El fenómeno es multifactorial y requiere diagnóstico diferencial.

CÓMO SE REPRESENTA TOURETTE EN TIKTOK

Un análisis cualitativo publicado en 2025 encontró que los mensajes informativos eran en gran parte correctos, pero síntomas llamativos como coprolalia, agresión y tics complejos recibían una atención desproporcionada. El resultado puede ser una imagen pública desequilibrada aunque parte de la información sea correcta.

DCD / DISPRASIA: 524 PUBLICACIONES

Un análisis de 524 tuits de personas que se identificaban con DCD/disprasia mostró impacto a lo largo de la vida en habilidades motoras, trabajo, adaptaciones, dolor/fatiga, conducción, salud emocional y estrategias compensatorias. El 63,9 % de los tuits codificados incluía defensa, concienciación o apoyo a otras personas y el 39,1 % recursos, información o educación.

12. REDDIT Y GRANDES CONVERSACIONES ONLINE

740.042	16	NLP	NO
publicaciones sobre autismo analizadas en Reddit	subreddits comparados en el estudio	modelado de temas a gran escala	equivale a muestra clínica representativa

El análisis masivo de Reddit identifica temas que aparecen espontáneamente en las comunidades: relaciones sociales, sensibilidad sensorial, diagnóstico, intervenciones, vida cotidiana y experiencias personales. Este tipo de estudio permite escuchar conversaciones que no fueron provocadas por un cuestionario.

QUÉ APORTA REDDIT

Permite estudiar lenguaje, necesidades, barreras y preocupaciones a una escala difícil de alcanzar con entrevistas. También puede revelar cómo cambian los temas con el tiempo y cómo se acercan los discursos de autismo y TDAH.

QUÉ NO APORTA

No permite asumir que todos los autores tengan diagnóstico confirmado, que representen a toda la población neurodivergente ni que la frecuencia de un tema equivalga a su prevalencia clínica.

13. ACCESIBILIDAD DIGITAL: UNA PIEZA CENTRAL

La literatura ampliada refuerza una idea que debería ocupar más espacio en FAND: la experiencia no depende solo del usuario. También depende de cómo está diseñada la plataforma.

Barrera	Posible impacto	Qué debería favorecer un diseño inclusivo
Lectura/escritura intensiva	Fatiga, exclusión, dificultad para participar	Multimodalidad, lenguaje claro, ayudas de escritura
Normas sociales implícitas	Malentendidos y ansiedad	Reglas explícitas, controles comprensibles
Ambigüedad y rapidez	Sobrecarga o respuestas impulsivas	Más control del ritmo y posibilidad de revisar
Algoritmo opaco	Repetición y burbujas de contenido	Controles de recomendación y transparencia
Privacidad compleja	Mayor vulnerabilidad	Configuraciones simples y comprensibles
Moderación deficiente	Acoso, estigma, explotación	Moderación accesible y mecanismos de denuncia claros
Poca representación	Sensación de no pertenecer	Diversidad real de edades, géneros, culturas y necesidades

14. QUÉ SABEMOS SEGÚN LA PLATAFORMA

Plataforma	Fortaleza para investigar	Riesgos / límites observados
TikTok	Vídeo breve, identidad, experiencia personal, gran alcance	Simplificación, contenido engañoso, tests virales, sesgo algorítmico
Reddit	Conversaciones extensas y comunidades temáticas	Anonimato, autoselección, diagnóstico no verificable
X / Twitter	Análisis longitudinal de discurso y experiencias públicas	Mensajes breves, polarización, cambios de plataforma
Facebook	Grupos, apoyo, vínculos y comunidades	Privacidad, alfabetización, moderación, grupos cerrados difíciles de estudiar
YouTube	Contenido largo y educativo	Calidad muy variable; engagement no garantiza fiabilidad
Instagram	Identidad, narrativas y divulgación visual	Menos investigación específica que TikTok en este campo

NO EXISTE UNA ÚNICA «RED SOCIAL»

Agrupar todas las plataformas en una sola variable puede ocultar diferencias importantes: formato, algoritmo, duración, moderación, anonimato, comunidades y posibilidades de interacción cambian la experiencia.

15. AMPLIACIÓN DE LOS DATOS DE LA LÁMINA DE INSTAGRAM

AUTISMO · 133 VÍDEOS

27 % correctos, 41 % incorrectos y 32 % sobregeneralizados. **Interpretación:** describe una muestra de vídeos informativos muy vistos, no todo TikTok. Popularidad y exactitud no se correspondieron de forma fiable.

TDAH · 100 VÍDEOS

52 % engañosos, 27 % experiencias personales y 21 % útiles. **Interpretación:** una experiencia personal no es automáticamente desinformación; el problema surge al presentarla como regla universal o criterio diagnóstico.

#ADHDTEST · 50 VÍDEOS

46 de 50 (92 %) fueron clasificados como engañosos frente al cribado ASRS-v1.1. Los vídeos útiles concentraron solo 4 % de los 'me gusta', 1 % de los comentarios y 7 % de los favoritos.

REVISIÓN DE CALIDAD 2026

27 estudios y 5.057 publicaciones. La desinformación osciló entre 0 y 56,9 % según estudio; fue mayor en TikTok que en YouTube y mayor en neurodivergencia que en otros temas de salud mental. No debe interpretarse como una tasa universal.

EXPERIMENTO · 490 UNIVERSITARIOS

La desinformación produjo menos conocimiento correcto y, al mismo tiempo, mayor confianza en lo que los participantes creían saber. **No midió cuántos tenían realmente TDAH.**

USO PROBLEMÁTICO · 35.223 PARTICIPANTES

Metaanálisis de 15 estudios: asociación moderada entre síntomas de TDAH y uso problemático de redes (r=0,361; IC95 % 0,297-0,421). Asociación no significa causalidad.

16. LAS DOS CARAS DE LAS REDES

PUEDEN AYUDAR

- Comunidad y pertenencia
- Identidad y autoexpresión
- Apoyo entre iguales
- Acceso a experiencias similares
- Información y recursos
- Menor presión comunicativa para algunas personas
- Concienciación y visibilidad
- Estrategias y adaptaciones compartidas

PUEDEN PERJUDICAR

- Desinformación y sobregeneralización
- Tests virales y autodiagnóstico impreciso
- Ciberacoso y estigma
- Comparación social
- Privacidad y explotación
- Sobrecarga
- Uso problemático
- Representación sesgada
- Diseño poco accesible

LO QUE TODAVÍA NO SABEMOS

Faltan estudios causales; comparaciones directas entre plataformas; investigación en personas mayores; diversidad cultural, racial y socioeconómica; estudios en español; y evidencia específica sobre dislexia, DCD/disprasia, trastornos del lenguaje, Tourette, discalculia, disgrafía, altas capacidades y otros perfiles. También faltan más estudios codiseñados con personas neurodivergentes.

La ausencia de evidencia no debe confundirse con evidencia de ausencia.

17. QUÉ PUEDE HACER FAND CON ESTA EVIDENCIA

Línea	Aplicación práctica
Directorio de información fiable	Separar experiencia personal, divulgación profesional, guías clínicas y herramientas de cribado
Alfabetización digital	Enseñar a identificar fuente, fecha, evidencia, conflicto de interés, límites y lenguaje absoluto
Directorio de comunidades	Valorar seguridad, moderación, accesibilidad, edad, idioma y perfil al que se dirige
Escucha comunitaria	Recoger qué buscan realmente las personas: diagnóstico, apoyo, amistad, empleo, educación, adaptaciones o pertenencia
Accesibilidad	Evaluar lectura, escritura, carga sensorial, claridad, privacidad y control de interacción
Investigación propia	Priorizar perfiles y edades infrarrepresentados y publicar metodología transparente
Colaboración con divulgadores	No excluir la experiencia vivida: combinarla con referencias y límites claros

MENSAJE CENTRAL PARA DIVULGACIÓN

La experiencia vivida aporta conocimiento que la investigación clínica no siempre capta. La evidencia científica ayuda a saber qué puede generalizarse. Necesitamos ambas, sin confundir sus funciones.

18. CONCLUSIONES GENERALES

• **No existe un efecto único de las redes sociales sobre la neurodivergencia.**
• **Autismo y TDAH dominan la literatura;** otras neurodivergencias están claramente infrainvestigadas.
• **La comunidad online puede ser una fuente real de apoyo, identidad y pertenencia,** especialmente documentada en autismo y también presente en otros grupos.
• **La desinformación es un problema medible.** En TDAH y autismo, varios estudios de TikTok encuentran proporciones relevantes de contenido engañoso, incorrecto o sobregeneralizado.
• **La popularidad no es un indicador fiable de exactitud.**
• **La exposición a desinformación puede afectar el conocimiento:** el experimento con 490 universitarios encontró menos conocimiento correcto y mayor confianza tras ver desinformación sobre TDAH.
• **El uso problemático y el TDAH están asociados, pero la causalidad sigue abierta.**
• **Accesibilidad, privacidad, moderación y diseño algorítmico son parte del problema y de la solución.**
• **La experiencia personal no debe desacreditarse:** puede ser una puerta de entrada a comprensión y apoyo, pero no sustituye una evaluación diagnóstica.
• **FAND puede ocupar un espacio útil entre comunidad, evidencia y accesibilidad**, ayudando a que las personas sepan qué información están viendo y para qué sirve.

SÍNTESIS FINAL

Las redes pueden ser el principio de una respuesta, un lugar donde encontrar palabras para explicar una experiencia y una vía hacia comunidad o ayuda. El objetivo no debe ser apartar a las personas neurodivergentes de las redes, sino conseguir que dispongan de **información verificable, espacios seguros, diseño accesible y criterios claros para distinguir experiencia, orientación, cribado y diagnóstico**.

19. REFERENCIAS CIENTÍFICAS SELECCIONADAS Y VERIFICADAS

• Carter A, Gracey F, Moody J, Ovens A, Chatburn E. (2026). Quality, reliability and misinformation in mental health and neurodivergence content on social media: a systematic review. Journal of Social Media Research, 3(1), 30-47. DOI 10.29329/jsomer.84.

• Potter AL, O'Leary A, Incecik E, Rose K, Pavlopoulou G, Tibber MS. (2026). Social Media and Social (Dis)Connectedness in Autism and ADHD: A Systematic Review. Autism in Adulthood. DOI 10.1177/25739581261435559.

• O'Leary A et al. (2026). The Relationship Between Social Media Use and Self-Esteem in ADHD and Autism: A Scoping Review. Autism in Adulthood. DOI 10.1177/25739581261480482.

• Aragon-Guevara D et al. (2023). The Reach and Accuracy of Information on Autism on TikTok. Journal of Autism and Developmental Disorders. DOI 10.1007/s10803-023-06084-6.

• Yeung A, Ng E, Abi-Jaoude E. (2022). TikTok and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study of Social Media Content Quality. Canadian Journal of Psychiatry. DOI 10.1177/07067437221082854.

• Verma S, Sinha SK. (2024/2025). How evidence-based is the hashtag ADHD test (#adhdtest): a cross-sectional content analysis. Australasian Psychiatry. DOI 10.1177/10398562241291956.

• Branigan K. (2026). What is the quality of ADHD content on TikTok, and how might this affect self-diagnosis? A systematic literature review. Educational Psychology in Practice. DOI 10.1080/02667363.2026.2644889.

• Misinformation mayhem: the effects of TikTok content on ADHD knowledge, stigma, and treatment-seeking intentions. Experimental study, N=490. DOI 10.1007/s00787-025-02769-8; PMID 40471415.

• Ding J, Liu Z, Chao M. (2025). The association between problematic social media use and ADHD symptomatology: systematic review and meta-analysis. Journal of Psychiatric Research. DOI 10.1016/j.jpsychires.2025.07.009.

• Hassrick EM et al. Benefits and Risks: A Systematic Review of Information and Communication Technology Use by Autistic People. Autism in Adulthood. PMID 36601264.

• Autism and social media: a systematic review of the user experience. (2023). Advances in Autism. DOI 10.1108/AIA-01-2023-0001.

• Gabarron E, Skafle I, Nordahl-Hansen A, Wynn R. (2023). Social media interventions for autistic individuals: systematic review. Frontiers in Psychiatry. DOI 10.3389/fpsyt.2023.1089452.

• Triantafyllopoulou P, Clark-Hughes C, Langdon PE. (2022). Social Media and Cyber-Bullying in Autistic Adults. Journal of Autism and Developmental Disorders. DOI 10.1007/s10803-021-05361-6.

• Brennan E et al. (2025). Deconstructing Information About Autism Diagnosis in Adults on TikTok. Journal of Autism and Developmental Disorders. DOI 10.1007/s10803-025-07123-0.

• Building Community and Identity Online: A Content Analysis of Highly Viewed #Autism TikTok Videos. PMID 38435322.

• Caton S, Chapman M. (2016). The use of social media and people with intellectual disability: a systematic review and thematic analysis. DOI 10.3109/13668250.2016.1153052.

• van Alem JLL et al. (2025). Social Internet Use by People With Intellectual Disabilities: A Systematic Review and Thematic Synthesis. Journal of Intellectual Disability Research. DOI 10.1111/jir.13211.

• Shelton N et al. (2024). Social media use by young people with language disorders: a scoping review. Disability and Rehabilitation. DOI 10.1080/09638288.2024.2325039.

• Tics and TikTok: Functional Tics Spread Through Social Media. PMID 34765689.

• Bartholomeus K, Steyaert JG. (2025). Portrayal of tics and Tourette's syndrome on TikTok: qualitative analysis. PMID 41288561.

• #DCD/Dyspraxia in Real Life: Twitter Users' Unprompted Expression of Experiences With Motor Differences. PMCID PMC10810317; PMID 38274159.

• Autism Spectrum Disorders Discourse on Social Media Platforms: A Topic Modeling Study of Reddit Posts. PMID 40470703.

• The relationship between social media use and adolescent inattention and impulsivity: a systematic review. (2026). DOI 10.1016/j.ridd.2026.105237.

• Karasavva V, Mikami AY. (2026). Autism and ADHD social media short-form video content: a systematic review protocol. PLoS One. DOI 10.1371/journal.pone.0357837. **Protocolo: no contiene resultados finales.**

Fecha de actualización documental: 7 de octubre de 2026. La selección prioriza revisiones, artículos revisados por pares y registros biomédicos verificables. Este documento no sustituye una revisión sistemática formal ni asesoramiento clínico.